



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
TENTANG
PELAKSANA PROGRAM PENANGGULANGAN PENYAKIT
TUBERKULOSIS (P2 TBC) DENGAN STRATEGI DOTS**

No. PIHAK PERTAMA : 1371/U000000/2023-S0

No. PIHAK KEDUA : 440/2999/DKK/IX/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (11-09-2023), bertempat di Kota Makassar, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0114303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor **Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

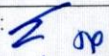
II. dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes, selaku **Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.22.3640-2021 dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Makassar, yang berkedudukan di Jl. Teduh Bersinar No. 1, Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan saling sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan

Perjanjian RSOJ PRB & Dinas Kesehatan Kota Makassar/2023

Halaman 1 dari 12

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



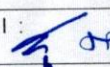
Tuberkulosis (P2 TBC) dengan strategi *Directly Observed Treatment Shortcourse* (DOTS), dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 **Pengertian Umum**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya** adalah sebuah rumah sakit yang telah terakreditasi yang berkedudukan di Kota Makassar yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan.
2. **Dinas Kesehatan Kota Makassar** adalah instansi yang bertanggungjawab mengenai kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Makassar memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan.
3. **Tuberkulosis (TBC)** adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
4. **Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)** adalah segala upaya kesehatan yang terdiri dari penemuan kasus, diagnosis, tatalaksana pengobatan sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanggulangan TBC
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Tuberkulosis.
5. **Strategi DOTS** adalah strategi pengendalian TBC yang terdiri dari 5 komponen, yaitu :
 - a. Komitmen politis
 - b. Pemeriksaan dahak bakteriologis yang terjamin mutunya
 - c. Pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TBC dengan tatalaksana yang tepat termasuk pengawasan langsung pengobatan
 - d. Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu
 - e. Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program
6. **Fasilitas pelayanan kesehatan** adalah tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang terdiri dari fasyankes tingkat pratama (puskesmas, praktek dokter, praktek dokter gigi, klinik pratama atau yang setara) dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan (klinik utama atau setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus, baik milik pemerintah maupun swasta).
7. Segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan,

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.

8. **Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)** adalah penemuan dan penyembuhan pasien untuk memutus rantai penularan sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di masyarakat
9. **Obat Anti Tuberkulosis (OAT)** adalah kombinasi dari beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan
10. **Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)** adalah Pengobatan yang diberikan kepada seseorang yang terinfeksi dengan kuman *Mycobacterium tuberculosis* dan berisiko sakit TBC.

Pasal 2 **Dasar Hukum**

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN** **Pasal 3**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk memberikan pelayanan tuberkulosis sesuai strategi *Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)* yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, memutuskan mata rantai penularan serta mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan TBC.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk membantu pemenuhan OAT (Obat Anti Tuberkulosis), alat penunjang pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Rumah Universitas Hasanuddin.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

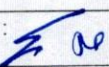
- (1) Ruang lingkup kerjasama secara umum meliputi bidang :
 - a. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar;
 - b. Pertemuan ilmiah untuk kepentingan **PARA PIHAK**;
 - c. Pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d. Sosialisasi/ pertemuan koordinasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - e. Pembentukan jejaring pelayanan; dan
 - f. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dilaksanakan oleh seluruh unit layanan yang ada di **PIHAK PERTAMA** seperti, meliputi:
 - a. Unit Rawat Jalan (umum dan spesialis);
 - b. Unit Gawat Darurat;
 - c. Unit Rawat Inap;
 - d. Unit Pelayanan Intensif;
 - e. Unit Kamar Bedah;
 - f. Unit Penunjang medis yakni Unit Laboratorium, Unit Radiologi;
 - g. Unit Farmasi;
 - h. Dokter/ Komite Medis; dan
 - i. Bidang Pelayanan Medis.

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **Sebelas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (11-09-2023) sampai dengan tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (10-09-2024).
- (2) **PARA PIHAK** harus menyampaikan maksudnya melalui surat pemberitahuan apabila hendak memperpanjang kerjasama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Dalam hal perpanjangan kerjasama, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama oleh Tim Evaluasi masing-masing pihak.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



BAB V

MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menyetujui dan memprioritaskan keselamatan pasien dalam evaluasi kerjasama ini.
- (2) Indikator mutu dan keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan kontrak.
- (3) Evaluasi perpanjangan kontrak dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak berakhir.
- (4) Indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai berikut :
 - a. Ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan semua kasus TB di **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Ketersediaan obat untuk penyakit TBC dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Tersedianya tenaga terlatih dalam penanggulangan penyakit TBC pada **PIHAK PERTAMA**
 - d. Kepatuhan pemberian informasi dan edukasi kepada pasien yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Penyelesaian komplain oleh **PARA PIHAK** baik secara lisan maupun tertulis paling lambat 1x24 jam.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 7

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan OAT dari **PIHAK KEDUA** untuk penyakit TB di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** yang penegakan diagnosisnya sesuai standar.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan fasilitas jejaring rujukan TCM
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. **PIHAK PERTAMA** membentuk poliklinik DOTS di rumah sakit dan menyiapkan sputum booth sebagai tempat mengambil dahak pasien;
 - b. **PIHAK PERTAMA** membentuk tim pelaksana program DOTS (Susunan Terlampir);
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengisi formulir pencatatan dan pelaporan penyakit TB dan melaporkan setiap penggunaan OAT Obat dan mengirimkannya kepada **PIHAK KEDUA** melalui SITB;
 - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan evaluasi setiap bulan Bersama internal rumah sakit yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berjalan;
 - e. **PARA PIHAK** berkewajiban memiliki PIC untuk berkomunikasi sehingga dapat memudahkan koordinasi penanganan Pasien **PIHAK PERTAMA**.

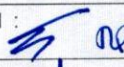
Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menyiapkan alat penunjang pemeriksaan, untuk terselenggaranya program tersebut dalam bentuk :
1. OAT kategori dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
 2. Alat dan bahan penunjang pemeriksaan seperti reagen Ziehl-Neelsen, pot sputum, kaca *specimen*.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan sosialisasi atau OJT kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan obat-obatan (OAT/ Obat Anti Tuberkulosis) kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan laporan penggunaan obat dan laporan evaluasi setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - d. **PARA PIHAK** berkewajiban memiliki PIC untuk berkomunikasi sehingga dapat memudahkan koordinasi penanganan Pasien **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** saling membantu melaksanakan Program Penanggulangan TB dengan Strategi DOTS dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab memberikan obat-obatan (OAT/ Obat Anti Tuberkulosis termasuk terapi pencegahannya), alat penunjang pemeriksaan, selama persediaan masih ada untuk terselenggaranya program tersebut dalam bentuk:
- a. OAT kategori 1, 2, Anak, Fixed Dose Combination (FDC), Kombipak.
 - b. Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).
 - c. Alat dan bahan penunjang pemeriksaan seperti reagen Ziehl-Neelsen, pot sputum, kaca *specimen*.
- (3) Proses pengadaan persediaan OAT dengan kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak pengajuan permintaan OAT.
- (4) Dalam melaksanakan program tersebut **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk :
- a. Membentuk poliklinik DOTS di Rumah Sakit Ibu dan Anak Paramount.
 - b. Membentuk Tim Pelaksana Program DOTS (Susunan Tim Terlampir).
- (5) Evaluasi dilaksanakan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan bagi perencanaan dan kegiatan Program P2 TBC selanjutnya.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan evaluasi setiap bulan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



- (7) Untuk menjaga mutu pemeriksaan spesimen sputum, maka **PARA PIHAK** melakukan *cross check* dan mengantarkannya untuk diperiksa kembali pada Laboratorium Kesehatan Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- (8) **PARA PIHAK** berkewajiban menyimpan dan mengumpulkan slide TBC yang sudah diperiksa untuk dilakukan *cross check*.
- (9) Pengiriman *cross check* slide TBC ditujukan Kepada Labkesda Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan periode setiap 3 bulan.
- (10) Apabila ada penderita TBC mangkir, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menginformasikan ke **PIHAK KEDUA** untuk melacak dan membawa kembali penderita ke RS rujukan Makassar untuk pengobatan selanjutnya.
- (11) Bila ditemukan terduga TBC – RO (Resisten Obat), **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan pada **PIHAK KEDUA** dan merujuk terduga TB – RO tersebut ke Fasilitas Rumah Sakit Rujukan Provinsi Sulawesi Selatan, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menangani setelah dinyatakan positif TBC – RO untuk mendapatkan pengobatan lanjutan di Puskesmas Satelit TBC – RO.
- (12) Penderita TBC dari **PIHAK PERTAMA** dapat berasal dari Puskesmas, Dokter Praktik, dan Klinik Swasta yang ada di wilayah Kota Makassar.
- (13) Koordinasi system rujukan dan jejaring antar Puskesmas, Rumah Sakit, maupun Swasta serta pengawasan minum obat dilakukan bersama-sama dengan Wakil Supervisor (WASOR) dari Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- (14) Pengobatan bagi semua pasien TBC adalah bersifat gratis untuk obat-obatan OAT.
- (15) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta Puskesmas sekitarnya mengadakan pertemuan koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSAI *FORCE MAJEURE*

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

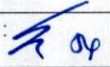
- (5) Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB IX

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya ketetapan, ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
 - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



- (6) Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerjasama.
- (7) Dalam hal pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir, maka tunggakan dalam perjanjian ini yang belum terselesaikan harus segera diselesaikan dan tetap menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Makassar.

BAB XI

ADDENDUM / AMANDEMEN

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak akan diubah dengan cara apa pun setelah penandatungannya, kecuali bila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian ini, maka akan dibuat dalam bentuk *Addendum / Amandemen* yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- (3) *Addendum / Amandemen* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

BAB XII

PEMBERITAHUAN (ADMINISTRASI)

Pasal 13

Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui email, ekspedisi, pos atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada :

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya

Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Telepon : (0411) 428 1000

PIC PIHAK PERTAMA :

1. Bagian Kerjasama

Nama : Melinda Sari Pratiwi
HP. : 082349792437
Email : legal.rsoj@gmail.com

2. Penanggung Jawab Pelayanan Pelaksana Program Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (P2 TBC) dengan Strategi DOTS

Nama : dr. Pratiwi Quranita. Sp.PD
Hp : 081334787800

3. Bagian Unit Farmasi

Nama : Apt. Sasmita, S.Farm
Hp : 082396067367

4. Bagian Pelaporan

Nama : Yuslana, S.Kep, Ns
HP : 082194243677

PIHAK KEDUA

DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

Jalan Teduh Bersinar No. 1, Gunung Sari

Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223

Telepon : (0411) 881549

1. Penanggung Jawab Pelayanan Pelaksana Program Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (P2 TBC) dengan Strategi DOTS

Nama : Sierli Natar, S.Kep
Diyah Fajarwati, SKM
HP. : 081342644868
085242223015
Email : sierlynatar@yahoo.com
diahsetiawan@yahoo.co.id

2. Bagian Instalasi Farmasi

Nama : Nur Afni Arif
HP. : 085242176061
Email : afnee_farma@ymail.com

3. Bagian Pelaporan

Nama : Viodetha Hermina, S.Kep., Ns

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



IHC
Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya



HP. : 085211500787
Email : gfviki0@gmail.com

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan tiap-tiap lembar Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing pihak memberi paraf pada sudut kanan bawah serta berlaku sah setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA


dr. Muhammad Ahsan, MARS

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS
KOTA MAKASSAR



dr. Nursaidah Sirahuddin, M.Kes
NIP. 197301122006042012

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

NOMOR Kpts-1320/U000000/2023 TANGGAL 30 AGUSTUS 2023

TENTANG TIM PELAYANAN *DIRECTLY OBSERVE TREATMENT SHORTCOURSE (DOTS)*

NAMA TIM DOTS

Pembina I	: dr. Muhammad Ahsan, MARS
Pembina II	: Sunarto
Penanggung Jawab	: dr. Pratiwi Quranita, Sp.PD
Ketua	: dr. Edward Pandu Sp.p
Wakil Ketua	: dr. Lingga Pradipta, Sp.A
Sekretaris	: Yusliana, S.Kep, Ns
Anggota	:
	1. Sartika Sitanggang, S.Kep, Ns
	2. Hariza, Amd.Ak
	3. apt. Sasmita S.Fam
	4. Mario Al Anshari S.Kep
	5. Reski Amalia Amd.Kep

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 